



GUIA GRATUITO · WEBINÁRIO ITH

Precauções e isolamento: tabela de consulta rápida

Por que cada precaução existe, como um isolamento falha na prática, tabela por doença e checklist de auditoria do leito.

WEBINÁRIO COM

Esp. Juliana Dias

Embaixadora do MBA em SCIRAS e Segurança do Paciente



O PORQUÊ DE CADA PRECAUÇÃO

A precaução segue o caminho do microrganismo

Precaução	Como o agente se espalha	EPI e quarto
Padrão	Qualquer paciente pode estar colonizado sem saber; sangue e fluidos são sempre potencialmente infectantes	Higiene das mãos; luvas, avental, máscara e óculos se houver risco de respingo; descarte seguro de perfurocortantes. Vale para todos .
Contato	Mãos, luvas, roupas e equipamentos que tocam o paciente ou as superfícies próximas	Luvas e avental ao entrar; quarto privativo ou coorte; estetoscópio, termômetro e esfigmo exclusivos
Gotículas	Partículas > 5 µm da tosse e da fala, que caem em cerca de 1 metro	Máscara cirúrgica ao entrar; quarto privativo ou coorte; paciente com máscara no transporte
Aerossóis	Partículas < 5 µm que ficam suspensas no ar e circulam pelo ambiente	Respirador PFF2/N95 antes de entrar; porta fechada; quarto preferencialmente com pressão negativa

CASO ILUSTRATIVO · SITUAÇÃO COMPOSTA A PARTIR DE OCORRÊNCIAS COMUNS, COM DADOS FICTÍCIOS

Três casos de KPC em dez dias

Um paciente da UTI tem cultura de vigilância positiva para enterobactéria produtora de carbapenemase (KPC). A precaução de contato é prescrita, mas a placa só é colocada no dia seguinte. Nesse intervalo, o estetoscópio do leito é usado em outros dois pacientes e o avental é reaproveitado entre leitos "porque era o mesmo procedimento". Em dez dias, mais dois pacientes da UTI têm KPC.

O que falhou: sinalização atrasada (furo 1), equipamento compartilhado (furo 2) e EPI reaproveitado entre pacientes (furo 3). Nenhum dos três furos é falta de conhecimento técnico: são falhas de processo que uma auditoria simples, como a da página 5, encontra.

PARAMENTAÇÃO

Colocar (fora do quarto)

- 1 Higiene das mãos
- 2 Avental
- 3 Máscara ou respirador (teste de vedação)
- 4 Óculos ou protetor facial
- 5 Luvas sobre o punho do avental

Retirar

- 1 Luvas
- 2 Óculos/protetor, pelas hastes
- 3 Avental, enrolando pelo avesso
- 4 Higiene das mãos
- 5 Máscara/respirador pelos elásticos (respirador fora do quarto) e nova higiene

Por que essa ordem: as luvas são o item mais contaminado e saem primeiro; a máscara protege a via respiratória e sai por último, quando as mãos já estão limpas.

CONSULTA RÁPIDA

Precaução por doença ou agente

Doença / agente	Precaução	Observação
Bactérias multirresistentes (ex.: MRSA, enterobactérias produtoras de carbapenemase)	Contato	Conforme política da CCIH
<i>Clostridioides difficile</i>	Contato	Higiene das mãos com água e sabão (álcool não elimina esporos)
Escabiose, pediculose	Contato	Até 24 h após o tratamento eficaz
Diarreia infecciosa em paciente incontinente ou com fralda	Contato	Durante o quadro
Influenza	Gotículas	Somar aerossóis em procedimentos geradores de aerossol
Doença meningocócica	Gotículas	Até 24 h de antibioticoterapia eficaz
Coqueluche	Gotículas	Até 5 dias de tratamento eficaz
Caxumba, rubéola	Gotículas	Conforme o período de transmissão
Tuberculose pulmonar ou laringea (suspeita ou confirmada)	Aerossóis	Respirador PFF2/N95; suspender conforme critério clínico e da CCIH
Sarampo	Aerossóis	Profissionais suscetíveis não devem entrar
Varicela; herpes-zóster disseminado ou em imunossuprimido	Aerossóis + contato	Até todas as lesões em crosta
COVID-19	Gotículas + contato	Aerossóis em procedimentos geradores de aerossol

FERRAMENTA PARA IMPRIMIR

Checklist de auditoria do isolamento

Setor: _____ Data: _____ Leito: _____ Tipo de precaução: _____

Auditor: _____

#	Item verificado	Sim	Não	N/A
1	Precaução prescrita e compatível com o agente ou a suspeita	☐	☐	☐
2	Placa de sinalização na porta, com tipo de precaução e EPIs	☐	☐	☐
3	EPIs disponíveis na entrada do quarto	☐	☐	☐
4	Preparação alcoólica disponível na entrada e à beira do leito	☐	☐	☐
5	Equipamentos de uso exclusivo do paciente (estetoscópio, termômetro, esfigmo)	☐	☐	☐
6	Profissional coloca o EPI antes de entrar (observado)	☐	☐	☐
7	Profissional retira o EPI na ordem correta e higieniza as mãos (observado)	☐	☐	☐
8	Respirador PFF2/N95 em uso correto (aerossóis), sem estar abaixo do nariz	☐	☐	☐
9	Porta fechada (aerossóis)	☐	☐	☐
10	Paciente transportado com máscara cirúrgica (gotículas/aerossóis)	☐	☐	☐
11	Critério de suspensão do isolamento registrado no prontuário	☐	☐	☐

CÁLCULO RESOLVIDO

Conformidade do mês

Conformidade dos isolamentos = auditorias sem nenhuma falha ÷ auditorias realizadas × 100

= 21 ÷ 30 × 100 = **70%**

Leitura: liste quais itens mais falharam nas 9 auditorias não conformes. Se for o mesmo item (ex.: placa), a correção é de processo, não de treinamento individual.



PRÓXIMO PASSO

Quer aprofundar este tema ao vivo?

Este guia resume os pontos centrais. No webinar gratuito com a Esp. Juliana Dias, você vê os exemplos da rotina e tira suas dúvidas no chat.

Webinário gratuito: Precauções e isolamento

Online e ao vivo. Inscreva-se e receba a data e o link no WhatsApp e no e-mail.

Quero me inscrever grátis

mkt.faculdadeith.com.br/lp/webinario-precaucoes-isolamento/

MBA em SCIRAS e Segurança do Paciente - 100% EAD

Controle de infecção, gestão de riscos, acreditação e núcleo de segurança do paciente. 440 horas, diploma reconhecido pelo MEC (ITH, conceito 5).

Conhecer o MBA

Fontes

- ANVISA. Medidas de Prevenção de IRAS e materiais de precauções e isolamento.
- CDC/HICPAC. 2007 Guideline for Isolation Precautions.
- CDC. Sequence for Putting On and Removing Personal Protective Equipment.